



Frau

Luisa O. [REDACTED]

Zürich, 01.09.2025

O. [REDACTED], Luisa, [REDACTED]
"GATSBY", Katze, Sibirische Katze, männlich kastriert, geb. 26.07.2022

Patientenbericht

Eintrittsdatum

25.08.2025

Austrittsdatum

27.08.2025

Grund der Konsultation

Chronische Lahmheit der linken Vordergliedmasse (seit Juli 2025)
Kein offensichtliches Trauma

Befunde

Klinik:

Vitalparameter in den Norm

Vergrößerung der linken präskapulären Lymphknoten

Orthopädische Untersuchung:

- Gang: Lahmheit 5/5 der linken Vordergliedmasse
- Schwellung der Pfote bis proximales Antebrachium links, Schmerzhaft Palpation lateral der gesamter Gliedmasse
- Kleine Wunde und Rötung zwischen 3. und 4. Phalanx links

Labor (siehe bitte Anhang)

Bildgebende Diagnostik (Hauptbefunde):

- Computertomographie der linken Vordergliedmasse (CT)

Radiologische Befunde:

Helikale CT-Untersuchung der linken Vordergliedmasse; skelettal adulte Katze; Wiederholung der Untersuchung in der Equilibriumsphase nach i.v.-Applikation iodhaltigen Kontrastmittels (KM):

Unschärf definierte, permeative Lyse distal am Os metacarpale IV, abaxial deutlicher als axial. Einbezug der palmaren Sesambeine, deutlicher am abaxialen, mit mittelgradigem Substanzverlust. Weniger deutlich am proximalen Anteil der Phalanx proximalis der 4. Zehe. Hochgradige, zirkumferente Weichteilschwellung akzentuiert auf die Articulatio metacarpophalangea IV links, mit hochgradiger, dort zirkumferenter KM-Anreicherung; proximale Ausdehnung bis mid-diaphysär des Os metacarpale IV palmar betont; distale Ausdehnung bishin zur Phalanx distalis, ebenfalls palmar betont; axiale und abaxiale Ausdehnung in die Interdigitalspalten. Insgesamt dem Verlauf der Sehne des M. flexor digitorum profundus dieser Zehe folgend. Nach KM-Gabe Hervortreten eines relativ hypoattenuierenden Bereichs um die Sehne (Bereich der Sehnenscheide des M. flexor digitorum profundus der betroffenen Zehe).



Hochgradig vergrößerter cervicaler superficialer Lymphknoten links (ca. 1.8 cm DM), mit hochgradiger, insgesamt heterogener KM-Anreicherung.
Leichtgradig vergrößerter akzessorischer axillärer Lymphknoten links, mit hochgradiger, insgesamt heterogener KM-Anreicherung.

Radiologische Diagnose:

- Hochgradige Arthritis der Art. metacarpophalangea IV links, mit polyostotischer Osteomyelitis, hochgradiger Tendovaginitis der Sehne des M. flexor digitorum profundus (4. Zehe) und begleitender hochgradiger Weichteilschwellung akzentuiert um die 4. Zehe.
- Hochgradige cervicale superficiale Lymphadenomegalie links.

Schlussfolgerungen:

Die Befunde sind verdächtig für eine septische Arthritis und Tenovaginitis des M. flexor digitorum profundus sowie Phlegmone und reaktiver regionaler Lymphadenomegalie (z.B. nach Biss, Tritt in einen spitzen Gegenstand). Fremdmaterial wie kleine pflanzliche Bestandteile sind nicht sichtbar, jedoch ist deren Vorliegen dennoch möglich.
Neoplastische Ursache wie (Fibro)Sarkom, Plattenepithelkarzinom wenig wahrscheinlich.

- Ultraschal Weichteil (linke Vordergliedmasse)

Radiologische Befunde:

Ultrasonographische Untersuchung der linken distalen Vordergliedmassen:

Hgr. und zirkulär, lgr korpuskuläre Dilatation der Sehnenscheide um die Endsehe des M. digitorum extensor IV. Faserverlauf der Sehne unauffällig.

Palmarolateral auf der Höhe der proximalen Kontur des Os carpi accessorium sind in einem der Flexoren (am wahrscheinlichsten M. flexor carpi ulnaris) punktförmige hyperechogene Foci wiederholt sichtbar. Die Muskulatur weist eine erhaltene und regelrechte Echogenität und -textur auf.

Auf Höhe der Metacarpalia sind entlang der palmaren Kontur zwischen den tiefen Flexoren (Mm lumbricales) und den oberflächlicher gelegenen Sehnen des M. flexor digitorum superficialis einzelne kleine Zonen mit korpuskulärem Inhalt sichtbar.

Hgr gefüllte Sehnenscheide um den distalen Anteil des

Dorsal im Bereich der punktförmigen Wunde im Interdigitalspalt 3./4. Zehe ist das

Metacarpophalangealgelenk der 4. Zehe vermehrt gefüllt. Die Gelenkränder sind lgr unregelmässig.

Radiologische Diagnose:

Linke distale Vordergliedmasse

Mgr Dilatation der Beugesehnenscheide des vierten Os metacarpale

Hgr. Verdacht auf (septische) Arthritis des Metacarpophalangealgelenks 4

Unregelmässige Gelenkränder des Metacarpophalangealgelenks 4 dorsal- DDx Osteoarthrose vs. Osteitis vs. Osteomyelitis

Multifokale kleine Flüssigkeitsansammlungen entlang der palmaren Kontur der Metacarpalia

Schlussfolgerungen:

Hgr. Verdacht auf das Vorliegen einer vermutlich septischen Tenovaginitis der

Flexorsehnenscheide des 4. Metacarpus

Hgr. Verdacht auf das Vorliegen einer Phlegmone entlang der distalen linken Vordergliedmasse-akzentuiert palmar.

Die Ursache der hyperechogenen Foci auf Höhe des Os carpi accessorium bleibt offen. Mögliche DDx: Kleine Gasansammlung, Fibrose, kein eindeutiger Hinweis auf das Vorliegen von Fremdmaterial, da keine periphere Halo-bildung oder Heterogenität der Muskulatur mit diesen Foci assoziiert ist.

Die Flüssigkeitsansammlungen waren zu gering für eine sichere Punktion.

Diagnose/Verdachtsdiagnose

Phlegmone der linken Vordergliedmasse und Anzeichen von Osteomyelitis bei der linken distalen Extremität (linke Pfote, 4. Zehe)

Therapie im Tierspital



- Stationäre Behandlung mit intravenöser Verabreichung von Antibiotika und Analgetika
- Engmaschige Überwachung des Allgemeinzustandes sowie des Verlaufs der Schwellung/Dolenz an der linken Vordergliedmaße
- Punktion der linken präskapulären Lymphknoten:
Milde reaktive Hyperplasie (Vergrößerung) (nichtspezifischer Befund sekundär zu antigenen Stimulation)

Nachbehandlung

Medikamente:

- Clavaseptin 250mg. 1/2 tabl dreimal täglich für 4 Wochen ab 27.08.2025 Abend
- Gabapentin 50mg. 1 tabl dreimal täglich für 2 Wochen
- Buprenorphine Lösung. 0.3ml zwei-dreimal täglich für 1-2 Tage ab 27.08.2025 Abend

Fütterung:

Wie gehabt

Haltung:

Ruhhaltung für die nächste 1-2 Wochen.

Bitte kontrollieren Sie Gatsbys Pfote auf Schmerzen oder Schwellungen. Sollte eine Lahmheit, Schmerz oder eine Schwellung auftreten, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf.

Nachkontrolle

Ein weiterer Kontrolltermin bezüglich der Pfote ist nur im Falle von Komplikationen erforderlich (z. B. Schwellung, Schmerzen oder Rezidiv nach der Verabreichung von Medikamenten).

Aufgrund der leicht erhöhten Nierenwerte wird eine Blutuntersuchung in 2–4 Wochen empfohlen.

Kommentar

Gatsby wurde mit Verdacht auf eine bakterielle Entzündung der Weichteile der linken Pfote und des Unterarms mit diffuser Phlegmone mit Herden einer Osteomyelitis (Anzeichen von Knocheninfektion) an der linken Vordergliedmaße unklarer Ursache diagnostiziert. Ein kleiner Fremdkörper kann die Ursache sein, es konnten aber kleine Flüssigkeitsansammlung oder Fremdkörper selbst festgestellt werden. Deshalb wurde eine konservative Therapie mit Antibiotika und Schmerzmittel begonnen, auf die Gatsby gut angesprochen hat. Eine chirurgische Behandlungsindikation gab es momentan nicht.

Gatsby sprach gut auf die Behandlung an und zeigte bereits nach einem Tag eine deutliche Verbesserung des Gangbildes; die Schwellung war nahezu vollständig zurückgegangen. Bitte führen Sie die Antibiotikatherapie konsequent fort und kontaktieren Sie uns bei eventuellen Problemen.

Obwohl in der bildgebenden Diagnostik kein Fremdmaterial nachgewiesen wurde, kann dessen Vorhandensein nicht ausgeschlossen werden. Sollte eine Restschwellung bestehen bleibe, oder wieder auftreten, können weitere bildgebende Untersuchungen sowie gegebenenfalls ein chirurgischer Eingriff notwendig werden.

Beilagen

Clavaseptin 250mg

Gabapentin 50mg

Buprenorphine Lösung

Hinweise zur Medikamentenabgabe

Aufgrund der vorgegebenen Packungsgrößen kann die abgegebene Medikamenten-menge von der hier angegebenen Menge abweichen. Bei kontinuierlicher Medikamenten-abgabe sind regelmässige Kontrollen notwendig. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben müssen die Patienten mindestens einmal jährlich am Tierspital Zürich vorgestellt werden.

Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Nachbehandlung und wenden sich bei Fragen oder Unklarheiten an uns (044 635 81 11/12). Die Beratungen werden je nach Aufwand in Rechnung gestellt.



Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Freundliche Grüsse

med. vet. Dimitrios Bekiaridis

Dr. med. vet. DipECVS Heidi Radke

Halter-ID: 2471839

Patient: Katze (sibirische Katze) GATSBY
(männlich)

Tierhalter: C. [REDACTED] Luisa

Geb.-Datum: 26.07.2022

KG-Nr.: [REDACTED]

Hämatologie-Befunde

Auftrag 51234016, Eingang 25.8.2025 13:51:33 (Entnahme: 25.8.2025 13:07:25)

Parameter	Wert	Einheit	Referenzintervall
EDTA-Blut			
Hämatokrit	37	%	33.0 - 45.0
Hämoglobin	12.9	g/dl	11.3 - 15.5
Erythrozyten	9.44	*10E6/ul	7.0 - 10.7
Eo-Verteilungsbreite	18.2	%	
MCH	14	pg	14.0 - 17.0
MCHC	35	g/dl	33.0 - 38.0
MCV	39	fl	40.0 - 48.0
Leukozyten	20.1	*10E3/ul	4.6 - 12.8
Normoblasten %	0	%	
Normoblasten	0	*10E3/ul	
Thrombozyten	329	*10E3/ul	180.0 - 680.0
Retikulozyten	0.18	%	
Retikulozyten	0.017	*10E6/ul	
Retikulozyten	16992	/ul	0.0 - 43850.0
Retikulozyten Hämoglobin	16.6	pg	
Neutrophile (auto.)	12.66	*10E3/ul	2.3 - 10.0
Eosinophile (auto.)	0.61	*10E3/ul	0.1 - 0.6
Basophile (auto.)	0.05	*10E3/ul	0.0 - 0.1
Monozyten (auto.)	0.88	*10E3/ul	0.0 - 0.7
Lymphozyten (auto.)	5.92	*10E3/ul	1.1 - 6.0
Neutrophile% (auto.)	63	%	
Eosinophile% (auto.)	3	%	
Basophile% (auto.)	0.2	%	
Monozyten% (auto.)	4.4	%	
Lymphozyten% (auto.)	29.4	%	
Tc in Aggregaten	viel		
Anisozytose	wenig		

Chemie-Befunde

Auftrag 51234016, Eingang 25.8.2025 13:51:33 (Entnahme: 25.8.2025 13:07:25)

Parameter	Wert	Einheit	Referenzintervall
Heparin-Plasma			
Bilirubin gesamt	<2.5	umol/l	0.1 - 3.5
Glukose im Serum/Plasma	6	mmol/l	4.0 - 9.0



Parameter	Wert	Einheit	Referenzintervall
Harnstoff	10.3	mmol/l	7.4 - 12.6
Kreatinin	171	umol/l	98.0 - 163.0
Protein (Biuret)	72	g/l	64.0 - 80.0
Albumin	35	g/l	32.0 - 42.0
Globulin (berechnet)	37	g/l	
Cholesterin	7.4	mmol/l	2.6 - 6.8
Triglyzeride	0.2	mmol/l	0.3 - 1.3
Alkalische Phosphatase	49	U/l	16.0 - 43.0
Lipase	11	U/l	6.0 - 21.0
ASAT (GOT)	16	U/l	19.0 - 44.0
ALAT (GPT)	30	U/l	34.0 - 98.0
CK	174	U/l	77.0 - 355.0
Natrium indirekt	146	mmol/l	150.0 - 157.0
Kalium	4.3	mmol/l	3.8 - 5.4
Chlorid indirekt	113	mmol/l	113.0 - 123.0
Calcium	2.55	mmol/l	2.4 - 2.8
Phosphat	1.85	mmol/l	0.9 - 1.8
Serumamyloid A	1.5	mg/l	< 3.9
Referenzwert aus der Literatur			